



# Guida di Valutazione Fisica

Scale validate, test funzionali e schede stampabili per misurare i progressi del paziente anziano — e dimostrarli in modo oggettivo alla famiglia, al medico e ai colleghi.

- 8 scale cliniche standard con tabelle di scoring complete
- Protocollo di prima valutazione in 45 minuti
- 6 schede pronte da stampare (anamnesi, diario, cadute, report famiglia)
- Come restituire i punteggi senza allarmare né minimizzare

# Indice

Sei sezioni, dalla ragione clinica della valutazione alle schede pronte per la tua cartella.

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 · Perché valutare (e perché il 90% non lo fa)</b>         | <b>04</b> |
| <b>2 · Le 8 scale essenziali del fisioterapista geriatrico</b> | <b>07</b> |
| <b>3 · Il protocollo di valutazione completa in 45 minuti</b>  | <b>21</b> |
| <b>4 · Schede stampabili · 6 template</b>                      | <b>27</b> |
| <b>5 · Comunicare i risultati (famiglia, medico, PAI)</b>      | <b>35</b> |
| <b>6 · Errori tipici della valutazione</b>                     | <b>38</b> |

# Perché valutare (e perché il 90% dei professionisti non lo fa)

La differenza tra **sentire** un progresso e **misurare** è la differenza tra la tua parola e un dato. E il dato apre porte che la parola chiude.

*Non valuti perché non hai tempo. E poi passi trenta minuti a spiegare alla figlia del paziente perché ti sembra che il papà stia meglio. Se avessi cinque minuti di scala Tinetti confrontata con quella di tre mesi fa, la conversazione durerebbe due minuti — e sarebbe una conversazione diversa.*

Il paradosso della valutazione geriatrica è che **tutti sanno che serve, quasi nessuno la fa**. Non per ignoranza clinica — le scale sono nel curriculum di ogni corso di laurea in fisioterapia. Per erosione operativa: la prima seduta è un incastro logistico, il paziente è stanco, la famiglia vuole "iniziare subito", e la valutazione formale slitta a "la prossima volta". La prossima volta non arriva mai.

## Cosa perdi quando non valuti in modo standardizzato

Non è una questione accademica. Non valutare in modo strutturato ha quattro costi concreti che paghi ogni settimana, spesso senza rendertene conto:

### COSTO 1 · PERDI LA TUA DIFENDIBILITÀ

Se un paziente cade dopo tre mesi con te e la famiglia chiede spiegazioni, "andava meglio" non è una risposta. Un Tinetti passato da 14 a 21 in dodici settimane sì.

### COSTO 2 · PERDI IL CONFRONTO CON TE STESSO

Senza baseline non sai se stai migliorando come clinico. Ogni paziente diventa un aneddoto isolato. Con le scale, dopo due anni hai un dataset — sai quali protocolli funzionano meglio sul tuo bacino.

### COSTO 3 · PERDI LA CONVERSAZIONE CON IL MEDICO

Il geriatra non legge le tue impressioni. Legge numeri. Un report con Barthel + MMSE + TUG parla la sua lingua e ti fa diventare interlocutore, non esecutore.

### COSTO 4 · PERDI LA MOTIVAZIONE DEL PAZIENTE

L'anziano che vede su carta che il TUG è sceso da 18" a 13" trova una ragione per continuare. Il "va meglio" del figlio della vicina di casa vale zero.

## Sentire non è misurare

La sensazione clinica è preziosa — dopo dieci anni di lavoro riconosci una perdita di forza dal modo in cui il paziente afferra il bracciolo. Ma la sensazione ha tre limiti che la misurazione non ha:

- **Non è comunicabile** — non puoi trasferirla a un collega che deve sostituirti né a un familiare che vive lontano.
- **Non è confrontabile nel tempo** — la tua sensazione di oggi è contaminata dalla sensazione di ieri. Un numero no.
- **Non regge in tribunale né in RSA** — dove serve documentazione firmata, la sensazione non esiste.

## REGOLA OPERATIVA

Ogni paziente ha una **valutazione baseline** nella prima o seconda seduta, una **rivalutazione trimestrale** (ogni 12 settimane) e una **rivalutazione straordinaria** dopo qualsiasi evento acuto (caduta, ricovero, cambio farmaco importante). Sono tre appuntamenti fissi che difendono il tuo lavoro.

## Documentazione: perché il foglio conta più del ricordo

Il foglio di valutazione firmato e datato è l'unico artefatto che sopravvive alla tua memoria e alla memoria del paziente. Va conservato — cartaceo o digitale — insieme al consenso informato, per almeno la durata prevista dalle norme professionali di riferimento. Non serve un software costoso: una cartellina per paziente con la scheda anamnestica davanti, le rivalutazioni in ordine cronologico dietro, e sei a norma con quasi tutto quello che ti verrà chiesto.

## Quando NON valutare

La valutazione standardizzata ha controindicazioni precise. Se il paziente è in una di queste condizioni, rimandi la valutazione formale e ti limiti a un'osservazione clinica minima:

### NON SOMMINISTRARE SCALE IN QUESTE CONDIZIONI

- **Fase acuta** — post-caduta nelle prime 48-72 ore, post-ricovero nei primi giorni a casa, sospetto trauma non ancora refertato.
- **Delirium o stato confusionale acuto** — i risultati sono inaffidabili e la somministrazione può agitare il paziente. Aspettare la risoluzione dell'episodio.
- **Rifiuto esplicito del paziente** — la valutazione non è mai imposta. Se rifiuta, si spiega il perché e si riprova nella seduta successiva.
- **Sintomi acuti in corso** — febbre, dolore severo non controllato, dispnea a riposo, ipotensione posturale non compensata.
- **Fatica estrema o giornata "no"** — meglio spostare la valutazione che ottenere un baseline falsamente basso che poi distorce tutte le rivalutazioni.

In tutti questi casi, annota sulla cartella *"valutazione rimandata — motivo: [X] — data prevista rivalutazione: [Y]"*. È documentazione anch'essa.

## Il mito del "non ho tempo"

La valutazione completa che troverai in Sezione 3 dura 45 minuti. Sono **due sedute annuali per paziente** — baseline + rivalutazione trimestrale × 4. Su un paziente che vedi due volte a settimana per un anno (circa 100 sedute), la valutazione occupa il **4% del tempo**. Il ritorno — famiglia più fiduciosa, medico che ti manda altri pazienti, difendibilità clinica — vale infinitamente di più.

# Le 8 scale essenziali del fisioterapista geriatrico

Otto strumenti standard della letteratura riabilitativa, con scoring completo, interpretazione e controindicazioni. Non serve conoscerle tutte a memoria — serve saperle scegliere.

*Queste otto scale coprono le quattro dimensioni della vita funzionale dell'anziano: autonomia nelle attività quotidiane, equilibrio e andatura, resistenza aerobica, stato cognitivo ed emotivo. Sono le stesse che il medico geriatra, la RSA e le linee guida internazionali usano come riferimento. Non le stai inventando — le stai adottando.*

## Come leggere ogni scheda-scala

Ogni scala di seguito ha la stessa struttura: **descrizione breve, quando somministrarla, tempo richiesto, tabella scoring completa, interpretazione dei punteggi, controindicazioni**. Puoi fotocopiare la pagina, pinzarla alla cartellina del paziente e usarla come promemoria fino a quando non l'avrai imparata.

## 1 · Barthel Index (ADL) 0 – 100 punti

**Cosa misura.** L'autonomia nelle 10 attività di vita quotidiana di base (Activities of Daily Living): alimentarsi, lavarsi, vestirsi, curare l'igiene personale, controllare intestino e vescica, usare il bagno, trasferirsi letto-sedia, deambulare, salire le scale.

**Quando somministrarla.** In ogni prima valutazione, senza eccezioni. È lo standard di riferimento — se scrivi "Barthel 65", ogni professionista sanitario in Italia sa cosa intendi.

**Tempo.** 8-12 minuti se ti risponde direttamente il paziente. 5-6 minuti se rispondi tu osservando o intervistando il caregiver.

| ATTIVITÀ                  | PUNTEGGIO                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione             | 10 indipendente · 5 aiuto per tagliare/spalmare · 0 dipendente                                        |
| Bagno / doccia            | 5 indipendente · 0 dipendente                                                                         |
| Igiene personale          | 5 lava viso, denti, si rade autonomo · 0 dipendente                                                   |
| Vestirsi                  | 10 completo (bottoni, zip, lacci) · 5 metà attività · 0 dipendente                                    |
| Controllo intestino       | 10 continente · 5 incidenti occasionali · 0 incontinente                                              |
| Controllo vescica         | 10 continente · 5 incidenti occasionali · 0 incontinente/catetere                                     |
| Uso del bagno             | 10 indipendente · 5 aiuto per equilibrio/vestiti · 0 dipendente                                       |
| Trasferimenti letto-sedia | 15 indipendente · 10 supervisione o aiuto minimo · 5 aiuto di 1-2 persone, si siede · 0 non collabora |
| Deambulazione             | 15 indipendente ≥45m · 10 con aiuto ≥45m · 5 in carrozzina ≥45m · 0 immobile                          |
| Scale                     | 10 indipendente · 5 con aiuto o supervisione · 0 incapace                                             |

**Interpretazione del punteggio totale.**

100 · Indipendente

91-99 · Dipendenza minima

61-90 · Dipendenza lieve

41-60 · Dipendenza moderata

21-40 · Dipendenza severa

0-20 · Totale

### CONTROINDICAZIONI

Non somministrare in fase acuta post-frattura o post-ictus nei primi 15 giorni: il punteggio sarà artificialmente basso e distorcerà le rivalutazioni. Aspetta stabilizzazione clinica. In pazienti con afasia grave, intervista il caregiver principale.

## 2 · IADL Lawton (Attività Strumentali)

0 – 8 (donna) / 0 – 5 (uomo)

**Cosa misura.** Le attività più complesse che permettono di vivere in comunità: usare il telefono, fare la spesa, cucinare, gestire la casa, lavare la biancheria, usare mezzi di trasporto, gestire i farmaci, gestire il denaro. Complementare al Barthel — un paziente può avere Barthel 100 e IADL 3, ed è già a rischio istituzionalizzazione.

**Quando somministrarla.** Sempre insieme al Barthel nella prima valutazione. È l'indicatore più sensibile del declino precoce.

**Tempo.** 6-10 minuti in colloquio con paziente + caregiver.

**Nota storica sui punteggi differenziati.** La scala originale del 1969 (Lawton & Brody) prevedeva un punteggio massimo diverso tra uomini e donne per riflettere il contesto socioculturale dell'epoca (uomini non valutati su spesa, cucina, casa, biancheria). Oggi molte cartelle cliniche usano la versione a 8 items per entrambi i sessi — decidi in base al protocollo della tua struttura e sii coerente nelle rivalutazioni.

| ATTIVITÀ            | SCORING (1 = AUTONOMO, 0 = DIPENDENTE)                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Usare il telefono   | 1 se cerca numeri, digita, risponde autonomo · 0 se non sa usarlo                  |
| Fare la spesa       | 1 se provvede in autonomia a tutte le necessità · 0 se dipendente                  |
| Preparare i pasti   | 1 se pianifica, cucina e serve pasti adeguati · 0 se ha bisogno di pasti preparati |
| Governo della casa  | 1 se mantiene la casa da solo o con aiuto occasionale pesante · 0 se non partecipa |
| Lavaggio biancheria | 1 se fa il bucato personale · 0 se totalmente delegato                             |
| Uso mezzi trasporto | 1 se viaggia autonomo su mezzi pubblici o guida · 0 se non si sposta               |
| Gestione farmaci    | 1 se assume i farmaci al dosaggio e orario corretti · 0 se non è in grado          |
| Gestione denaro     | 1 se gestisce da solo (pagamenti, banca, spese) · 0 se incapace                    |

**Interpretazione.** Punteggio pieno = indipendenza strumentale. Perdita di 1-2 items = allerta declino precoce. Perdita ≥ 3 items = valutazione multidimensionale approfondita e coinvolgimento medico curante consigliati.

### CONTROINDICAZIONI

Poco affidabile in pazienti istituzionalizzati da lungo tempo (RSA) dove molte attività strumentali sono strutturalmente delegate. In quel contesto, documenta comunque il punteggio ma interpreta con cautela: la dipendenza non è per forza clinica, può essere ambientale.

### 3 · Tinetti Balance & Gait

0 – 28 punti (16 equilibrio + 12 andatura)

**Cosa misura.** La performance dell'equilibrio statico e dinamico (16 punti) e la qualità dell'andatura (12 punti). È la scala di riferimento per la stima del rischio di caduta a domicilio.

**Quando somministrarla.** In ogni prima valutazione e obbligatoriamente dopo qualsiasi episodio di caduta o quasi-caduta. Rivalutazione trimestrale.

**Tempo.** 10-15 minuti — richiede uno spazio libero di almeno 4 metri lineari e una sedia senza braccioli.

| ITEM                                           | PUNTEGGIO MASSIMO |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sezione equilibrio (16 pt totali)</b>       |                   |
| Equilibrio da seduto                           | 0-1               |
| Alzarsi dalla sedia                            | 0-2               |
| Tentativi di alzarsi                           | 0-2               |
| Equilibrio in stazione eretta (primi 5")       | 0-2               |
| Equilibrio in stazione eretta prolungata       | 0-2               |
| Prova di Romberg (piedi uniti, occhi aperti)   | 0-1               |
| Prova di Romberg sensibilizzata (occhi chiusi) | 0-1               |
| Girarsi di 360°                                | 0-2               |
| Sedersi                                        | 0-2               |
| Spinta sternale (perturbazione)                | 0-2               |
| <b>Sezione andatura (12 pt totali)</b>         |                   |
| Inizio della deambulazione                     | 0-1               |
| Lunghezza e altezza del passo                  | 0-2               |
| Simmetria del passo                            | 0-1               |
| Continuità del passo                           | 0-1               |
| Traiettoria (deviazione)                       | 0-2               |
| Tronco (oscillazioni, uso di ausili)           | 0-2               |
| Appoggio (base larga vs. tallone-punta)        | 0-1               |

**Interpretazione — soglie di rischio caduta.**

≥ 25 · Rischio basso

19-24 · Rischio moderato

< 19 · Rischio elevato



### **CONTROINDICAZIONI**

Non eseguire in pazienti che al momento della valutazione presentano vertigini attive, ipotensione ortostatica non compensata, dolore osteoarticolare acuto, o che sono al primo giorno di introduzione/modifica di una terapia sedativa/antipertensiva. Rinvia di 48-72 ore. Non lasciare mai il paziente senza supervisione fisica durante la prova di Romberg e la spinta sternale.

## 4 • Berg Balance Scale (BBS) 0 – 56 punti

**Cosa misura.** L'equilibrio funzionale in 14 compiti di difficoltà crescente, ciascuno da 0 (incapace) a 4 (autonomo). È più fine del Tinetti sulla componente equilibrio ma non valuta l'andatura — spesso si usano insieme.

**Quando somministrarla.** Quando il Tinetti risulta a rischio moderato/elevato e serve una fotografia più dettagliata per pianificare il lavoro sull'equilibrio. Rivalutazione ogni 4-8 settimane se stai lavorando specificamente sull'equilibrio.

**Tempo.** 15-20 minuti — richiede sedia, cronometro, righello, gradino.

| #  | COMPITO                                                | NOTE OPERATIVE                    |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Da seduto ad alzato                                    | Senza uso delle mani              |
| 2  | Stare in piedi senza sostegno                          | Tempo: 2 minuti                   |
| 3  | Stare seduto senza sostegno                            | Tempo: 2 minuti, piedi appoggiati |
| 4  | Da alzato a seduto                                     | Controllo della discesa           |
| 5  | Trasferimenti (sedia-letto)                            | Osservare uso mani/aiuto          |
| 6  | Stare in piedi a occhi chiusi                          | Tempo: 10 secondi                 |
| 7  | Piedi uniti in piedi                                   | Tempo: 1 minuto                   |
| 8  | Raggiungere in avanti a braccio teso                   | Misurare cm di reaching           |
| 9  | Raccogliere oggetto da terra                           | Da posizione eretta               |
| 10 | Girare indietro guardando alle spalle                  | Sinistra e destra                 |
| 11 | Girare 360°                                            | In entrambe le direzioni          |
| 12 | Appoggiare piedi alternatamente su gradino             | Contare ripetizioni in 20"        |
| 13 | Stare in piedi con un piede davanti all'altro (tandem) | Tempo: 30 secondi                 |
| 14 | Stare in piedi su un solo piede                        | Tempo massimo raggiunto           |

### Interpretazione.

45-56 • Rischio basso di caduta

21-44 • Rischio medio, deambulazione con supervisione

0-20 • Rischio alto, spesso indicazione a carrozzina

### CONTROINDICAZIONI

Sospendere immediatamente il test se compaiono vertigini, pallore, diaforesi, dispnea, o se il paziente riferisce paura ingestibile. Non è un test di resistenza — è un test di equilibrio: se il paziente è già stanco per i test precedenti, spezza la valutazione in due sedute.

## 5 • Timed Up & Go (TUG)

tempo in secondi

**Cosa misura.** Il tempo necessario per alzarsi da una sedia, camminare 3 metri, girarsi, tornare e sedersi. Un singolo numero che sintetizza forza degli arti inferiori, equilibrio dinamico, controllo motorio e velocità del gesto.

**Quando somministrarla.** Sempre. È la scala più costo-efficace: 1 minuto, un cronometro, uno spazio di 3 metri. Ripetibile ogni 4 settimane senza affaticare il paziente.

**Tempo.** 2-3 minuti (incluse le istruzioni). Fai **due prove**: la prima come pratica, la seconda registrata.

| FASE          | PROCEDURA                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup         | Sedia con braccioli, altezza standard (~46 cm). Segna un punto sul pavimento a 3 metri esatti dai piedi davanti alla sedia.                                         |
| Istruzione    | "Al mio via, si alza, cammina fino al segno, si gira, torna, si siede. Vada al suo passo abituale, con le sue scarpe abituali e con l'ausilio che usa normalmente." |
| Cronometro    | Parte quando il gluteo si stacca dalla seduta. Si ferma quando il gluteo tocca di nuovo la seduta.                                                                  |
| Registrazione | Annota tempo in secondi (decimi ammessi), ausilio usato, note su qualità dell'esecuzione (esitazioni, doppio appoggio nel giro, ecc).                               |

**Interpretazione — soglie di rischio caduta a domicilio.**

< 10 sec • Autonomia normale

10-13.5 sec • Autonomia con lieve limitazione

13.5-20 sec • Rischio aumentato di caduta

> 20 sec • Rischio elevato, valutare ausili e ambiente

### PERCHÉ IL TUG È IL TUO MIGLIORE AMICO

È l'unica scala che puoi ripetere ogni settimana senza risultare invasivo. Un delta di 2-3 secondi in 8 settimane è un dato clinico che vale una conversazione con il medico. Tienilo sempre in cartella con una piccola tabella cronologica.

### CONTROINDICAZIONI

Non eseguire se il paziente ha dolore acuto agli arti inferiori, se ha avuto una caduta nelle ultime 48 ore, o se non è in grado di comprendere l'istruzione (in quel caso il tempo misura l'ubbidire, non il muoversi). Cammina sempre a mezzo passo dietro il paziente durante il test, mai davanti.

## 6 · Six-Minute Walk Test (6MWT) distanza in metri

**Cosa misura.** La distanza che il paziente percorre camminando al proprio passo abituale in un corridoio piano per 6 minuti. È il test standard per la resistenza aerobica sub-massimale e riflette bene la capacità funzionale globale — cardiovascolare, respiratoria, muscoloscheletrica.

**Quando somministrarla.** Non nella prima valutazione se il paziente è deconditioned. Introdurla dopo 4-6 settimane di lavoro, come baseline di resistenza, e ripeterla ogni 8-12 settimane.

**Tempo.** 6 minuti di test + 5-10 minuti di setup e recupero.

| ELEMENTO            | STANDARD                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso            | Corridoio piano di almeno 30 metri, marcato ogni 3 metri, con coni ai due estremi per la virata.                                                                                                  |
| Parametri pre-test  | Frequenza cardiaca a riposo, saturazione, pressione arteriosa, scala di Borg (percezione dello sforzo, 0-10).                                                                                     |
| Istruzione          | "Cammini avanti e indietro tra i due coni al passo che sente sostenibile per 6 minuti. Può rallentare, fermarsi e ripartire se ne ha bisogno. Non deve correre. Le dirò io i minuti che restano." |
| Rinforzi standard   | Solo frasi standardizzate ogni minuto: "Sta andando bene. Restano X minuti." Nessun altro incoraggiamento.                                                                                        |
| Parametri post-test | Alla fine: distanza totale in metri, frequenza cardiaca finale, saturazione finale, Borg finale, motivo di eventuali soste.                                                                       |

**Interpretazione.** La distanza normativa varia con età, sesso, altezza e peso. Come riferimento clinico generale per anziani over-70 non ospedalizzati:

> 400 m · Buona capacità funzionale

300-400 m · Capacità ridotta ma funzionale

200-300 m · Compromissione moderata

< 200 m · Compromissione severa

Il dato che conta di più nelle rivalutazioni è il **delta rispetto al proprio baseline**: un incremento  $\geq 30$  metri è considerato clinicamente rilevante.

### CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE E RELATIVE

- **Absolute:** angina instabile o infarto nelle ultime 4 settimane, aritmia non controllata, ipertensione severa non compensata, embolia polmonare recente.
- **Relative:** frequenza cardiaca a riposo  $> 120$  bpm, pressione sistolica  $> 180$  o  $< 90$  mmHg, saturazione a riposo  $< 88\%$ . In questi casi rimandare o consultare il medico curante prima di eseguire.
- **Sospendere durante il test** se compaiono: dolore toracico, dispnea intollerabile, crampi agli arti inferiori, vertigini, pallore severo, saturazione  $< 85\%$ .

## 7 · Mini-Mental State Examination (MMSE) 0 – 30 punti

**Cosa misura.** Lo stato cognitivo globale attraverso 11 sotto-prove: orientamento temporo-spaziale, memoria immediata e differita, attenzione e calcolo, linguaggio, prassia costruttiva. È lo screening cognitivo più usato in geriatria.

**Quando somministrarla.** In ogni prima valutazione — anche in pazienti apparentemente lucidi. Il declino cognitivo precoce spesso non è visibile in conversazione. Rivalutazione ogni 6 mesi salvo eventi acuti.

**Tempo.** 10-15 minuti. Serve foglio, penna, orologio, un oggetto semplice (es. matita).

**Nota professionale importante.** L'MMSE è uno **strumento di screening**, non uno strumento diagnostico. Segnala la necessità di approfondimento cognitivo — la diagnosi di demenza è medica, non riabilitativa. Il tuo ruolo è documentare il dato e comunicarlo al medico curante o al geriatra.

| AREA                       | PUNTEGGIO (ITEM · TOTALE AREA)                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientamento temporale     | 1 pt × 5 items (anno, stagione, mese, giorno del mese, giorno settimana) · totale 5 |
| Orientamento spaziale      | 1 pt × 5 items (stato, regione, città, luogo, piano) · totale 5                     |
| Memoria immediata          | 1 pt × 3 parole ripetute · totale 3                                                 |
| Attenzione e calcolo       | 1 pt × 5 (100 meno 7, per 5 volte — oppure "mondo" a rovescio) · totale 5           |
| Memoria differita          | 1 pt × 3 parole richiamate dopo qualche minuto · totale 3                           |
| Linguaggio · denominazione | 1 pt × 2 (mostrare 2 oggetti da nominare) · totale 2                                |
| Linguaggio · ripetizione   | 1 pt (ripetere una frase esatta) · totale 1                                         |
| Linguaggio · comprensione  | 1 pt × 3 (esecuzione di comando in 3 fasi) · totale 3                               |
| Linguaggio · lettura       | 1 pt (leggere ed eseguire "chiuda gli occhi") · totale 1                            |
| Linguaggio · scrittura     | 1 pt (scrivere una frase spontanea con soggetto e verbo) · totale 1                 |
| Prassia costruttiva        | 1 pt (copiare due pentagoni intersecati) · totale 1                                 |

**Interpretazione dei punteggi grezzi** (non aggiustati per età e scolarità — l'aggiustamento è compito del neuropsicologo).

27-30 · Assenza di deficit

24-26 · Deficit cognitivo lieve, approfondire

18-23 · Deficit moderato

< 18 · Deficit severo

### CONTROINDICAZIONI E LIMITI

- Non affidabile in pazienti con **bassa scolarità** (meno di 5 anni) — sottostima il funzionamento cognitivo reale. Usare correzioni normative validate.
- Non affidabile in pazienti con **disturbi sensoriali gravi** (cecità, sordità severa) — molti item richiedono lettura o ascolto.
- Non somministrare in **fase di delirium** o subito dopo un evento acuto.
- Non ripetere a distanza breve (< 30 giorni): effetto apprendimento.

## 8 · Geriatric Depression Scale (GDS-15) 0 – 15 punti

**Cosa misura.** La presenza di sintomi depressivi nell'anziano attraverso 15 domande a risposta sì/no, semplici, non stigmatizzanti. È specificamente disegnata per la popolazione geriatrica — evita i sintomi somatici che possono essere presenti anche senza depressione (fatica, insonnia).

**Quando somministrarla.** In ogni prima valutazione — la depressione è spesso invisibile e maschera o aggrava la disabilità. Rivalutazione ogni 3-6 mesi o in presenza di cambiamenti significativi (lutto, ricovero, perdita di autonomia).

**Tempo.** 5-8 minuti. Somministrata verbalmente o autosomministrata se il paziente sa leggere.

| #  | DOMANDA                                              | RISPOSTA<br>PATOLOGICA |
|----|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | È soddisfatto della sua vita?                        | No                     |
| 2  | Ha abbandonato molte delle sue attività e interessi? | Sì                     |
| 3  | Sente la sua vita vuota?                             | Sì                     |
| 4  | Si annoia spesso?                                    | Sì                     |
| 5  | È di buon umore la maggior parte del tempo?          | No                     |
| 6  | Teme che le stia per capitare qualcosa di brutto?    | Sì                     |
| 7  | Si sente felice per la maggior parte del tempo?      | No                     |
| 8  | Si sente spesso indifeso?                            | Sì                     |
| 9  | Preferisce stare a casa invece di uscire?            | Sì                     |
| 10 | Sente di avere più problemi di memoria degli altri?  | Sì                     |
| 11 | Pensa che sia bello essere vivo, ora?                | No                     |
| 12 | Si sente inutile così come è ora?                    | Sì                     |
| 13 | Si sente pieno di energia?                           | No                     |
| 14 | Pensa che la sua situazione sia disperata?           | Sì                     |
| 15 | Pensa che gli altri stiano meglio di lei?            | Sì                     |

Si assegna **1 punto per ogni risposta "patologica"** (colonna a destra). Somma finale su 15.

**Interpretazione.**

0-4 · Assenza di depressione

5-9 · Depressione lieve, monitorare

10-15 · Sospetto di depressione moderata/severa

### CONTROINDICAZIONI E COSA FARE SE PUNTEGGIO $\geq 10$

Non somministrare in pazienti con deterioramento cognitivo severo ( $\text{MMSE} < 15$ ): le risposte non sono affidabili. Se il punteggio è  $\geq 10$  o se il paziente risponde affermativamente a item legati alla disperazione (item 11, 14), **segnala al medico curante o al geriatra** nel referto: non è tuo compito diagnosticare né trattare la depressione, ma è tuo dovere professionale segnalarla. Nella comunicazione con la famiglia usa formulazioni prudenti: "ho rilevato indicatori che meritano un approfondimento medico", non "è depresso".

## Come scegliere: la matrice minima

Non serve fare tutte le 8 scale ad ogni paziente. La combinazione minima difendibile e sufficiente per la maggioranza dei pazienti anziani a domicilio è: **Barthel + IADL + Tinetti + TUG + MMSE + GDS-15**. Berg e 6MWT si aggiungono quando la clinica lo richiede (Berg se Tinetti indica lavoro sull'equilibrio, 6MWT se stai impostando un programma aerobico).

### LA REGOLA DEL CASSETTO

Tieni fotocopie pronte delle sei scale del pacchetto minimo in una cartella dedicata. Quando sai di avere una prima valutazione, ne prepari sei copie con nome e data la sera prima. La mattina non improvvisi: apri, valuti, archivia. Cinque minuti di preparazione risparmiano quaranta minuti di stress.

# Il protocollo di valutazione completa in 45 minuti

Una sequenza operativa collaudata, minuto per minuto, che tiene conto della fatica del paziente anziano e produce alla fine un quadro clinico completo firmabile.

*Quarantacinque minuti sono l'unico compromesso realistico: abbastanza per raccogliere dati solidi, abbastanza corti perché un anziano over-75 li sopporti senza calo di collaborazione. Sotto ci sono buchi. Sopra ci sono risposte inaffidabili.*

## Il principio dell'ordine

L'ordine dei blocchi non è casuale — segue la **curva di fatica cognitiva e fisica** dell'anziano. Si parte con l'anamnesi (conversazione, poco impegnativa), si prosegue con le scale ADL/IADL (ancora colloquio), si passa alle scale motorie quando il paziente è "caldo" ma non stanco, si finisce con quelle cognitive/emotive che possono essere fatte anche da seduto.

### SEQUENZA OTTIMALE — 45 MINUTI TOTALI

| TEMPO  | BLOCCO                 | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-5'   | Anamnesi mirata        | Dati anagrafici, farmaci in corso, patologie principali, cadute negli ultimi 12 mesi, ausili in uso, obiettivi dichiarati dal paziente e dal caregiver. Usare Scheda 1.                                                                        |
| 5-15'  | Autonomia funzionale   | Barthel Index (colloquio + osservazione) e IADL Lawton. Se il paziente è collaborante, coinvolgere anche il caregiver per triangolare le risposte.                                                                                             |
| 15-25' | Equilibrio e andatura  | Tinetti completo + TUG cronometrato. Se il Tinetti dà rischio moderato/elevato e resta tempo, aggiungere Berg. Se il paziente sembra sospettabile di buona resistenza, programmare 6MWT in una seduta dedicata separata (non aggiungerlo qui). |
| 25-35' | Cognitivo ed emotivo   | MMSE completo + GDS-15. Farli da seduto in ambiente tranquillo, senza televisione né interruzioni. Se il paziente mostra segnali di fatica, spezzare in due sedute (MMSE ora, GDS al prossimo appuntamento).                                   |
| 35-40' | Definizione obiettivi  | Con il paziente (e caregiver se presente) formulare 2-3 obiettivi funzionali SMART per il trimestre. Es: "salire i 12 gradini di casa senza sosta entro 12 settimane". Vanno scritti — non concordati a voce.                                  |
| 40-45' | Sintesi e restituzione | Restituzione orale sintetica al paziente (in linguaggio semplice), compilazione della Scheda 2 (Prima valutazione riassuntiva), programmazione della prossima seduta, appuntamento per rivalutazione trimestrale già segnato in agenda.        |

## Adattamenti tipici della sequenza base

Il protocollo di 45 minuti è una struttura, non un dogma. In pratica lo adatti in base a tre variabili che valuti nei primi 5 minuti di anamnesi:



### PAZIENTE FRAGILE O > 85 ANNI

Dividi la valutazione in **due sedute da 25 minuti**.

Sessione A: anamnesi + Barthel + IADL + TUG. Sessione B (7 giorni dopo): Tinetti + MMSE + GDS + obiettivi. Non ci sono premi per fare tutto in un giorno se il dato è distorto dalla fatica.

### PAZIENTE AD ALTA AUTONOMIA

Se Barthel è a 95-100 e IADL è pieno, riduci le scale motorie a Tinetti + TUG e passa più tempo su 6MWT e sulla progettazione di obiettivi ambiziosi. Le scale servono a mappare il gap, non a decorarlo.

### PAZIENTE CON DEFICIT COGNITIVO NOTO

Sposta MMSE al primo blocco (non ultimo) — la performance cognitiva è migliore quando il paziente è riposato. Coinvolgi sempre il caregiver per l'IADL e per gli obiettivi.

### POST-CADUTA O POST-RICOVERO RECENTE

Nei primi 15 giorni dopo l'evento, limitati ad anamnesi + Barthel + TUG. Le scale complete si somministrano quando il quadro è stabilizzato — tipicamente dalla terza settimana.

## Setting minimo indispensabile

Non serve un ambulatorio attrezzato. La valutazione completa si può fare in casa del paziente con questo materiale, che dovresti avere sempre nella borsa:

- **Cronometro** (basta lo smartphone) per TUG, Berg, 6MWT.
- **Metro a nastro** di almeno 3 metri, meglio se rigido, per marcare il percorso del TUG.
- **Fascetta di nastro adesivo colorato** per segnare i 3 metri del TUG e i tratti del corridoio 6MWT.
- **Sfigmomanometro e saturimetro** per il 6MWT.
- **Foglio di carta A4 e penna** per la prassia costruttiva del MMSE e per la scrittura spontanea.
- **Un oggetto semplice** (matita, orologio) per la denominazione MMSE.
- **Sedia con braccioli** — nella casa del paziente c'è quasi sempre; verifica nell'anamnesi.
- **Cartellina con le 6 scale fotocopiate** — vedi Scheda 2.

### OTTIMIZZAZIONE TEMPO — LA REGOLA DEI 3 BLOCCHI

Somministra il TUG **tre volte** durante la valutazione: una all'inizio (baseline) prima di stancare il paziente, una a metà (per vedere effetto fatica), una alla fine (dopo il MMSE). Non è ridondanza — è l'unico modo per capire se il paziente ha una "riserva funzionale" o è al limite già a riposo. Il dato clinico più utile è il delta tra TUG-inizio e TUG-fine.

## Cosa fai con i dati subito dopo

La valutazione non è finita quando esci dalla porta. È finita quando entra in cartella. Nel giro di 24 ore:

1. **Trascrivi i punteggi** nella cartella clinica del paziente (Scheda 2 compilata + firmata da te).
2. **Prepara il piano di lavoro** dei prossimi 4 appuntamenti sulla base dei deficit rilevati. Usa il Costruttore di Sedute (Bonus 4) per non partire da zero.
3. **Scrivi il report per la famiglia** (Scheda 6) — 1 pagina in linguaggio accessibile, con obiettivi trimestrali dichiarati.
4. **Se necessario, invia comunicazione al medico curante** — punteggi rilevanti, segnalazioni, richiesta di eventuale approfondimento (es. neuropsicologo se MMSE 24-26, geriatra se GDS  $\geq 10$ ).
5. **Segna in agenda la rivalutazione a 12 settimane** — bloccando il posto, non "quando capita".

La regola: **una valutazione non seguita da un piano scritto e da una rivalutazione in agenda è una valutazione sprecata**. Non hai raccolto dati — hai fatto compiti.

# Schede stampabili • 6 template

Sei fogli pronti da stampare in A4, pinzare alla cartellina del paziente e riempire a penna durante e dopo la seduta. Nessun software, nessun account: penna e carta.

*Ogni scheda è un template neutro — nessun logo, nessun contatto. Fotocopiala una volta, riempi una volta, archiviala una volta. Diventa parte della tua cartella clinica del paziente.*

## Scheda 1 • Anamnesi geriatrica (16 items)

| CAMPO                                                       | COMPILAZIONE |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Nome e cognome                                           | _____        |
| 2. Data di nascita / età                                    | _____        |
| 3. Sesso • scolarità (anni)                                 | _____        |
| 4. Contesto di vita (solo / famiglia / RSA / centro diurno) | _____        |
| 5. Caregiver principale (relazione, presenza h/giorno)      | _____        |
| 6. Patologie principali attive                              | _____        |
| 7. Interventi chirurgici rilevanti (data, tipo)             | _____        |
| 8. Farmaci in corso (numero e classe principale)            | _____        |
| 9. Ausili in uso (bastone, deambulatore, carrozzina)        | _____        |
| 10. Cadute negli ultimi 12 mesi (n° / gravità / dove)       | _____        |
| 11. Quasi-cadute nell'ultimo mese (n°)                      | _____        |
| 12. Dolore attuale (sede / intensità NRS 0-10)              | _____        |
| 13. Vista / udito (occhiali, apparecchio acustico?)         | _____        |
| 14. Attività fisica attuale (tipo, frequenza settimanale)   | _____        |
| 15. Obiettivo dichiarato dal paziente                       | _____        |
| 16. Obiettivo dichiarato dal caregiver                      | _____        |

**COMPILATO DA**

Nome professionista: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**DATA E LUOGO**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Luogo (domicilio/studio/RSA): \_\_\_\_\_

**Scheda 2 • Prima valutazione riassuntiva**

Riassunto operativo dei sei punteggi essenziali su una sola facciata — la tua "carta d'identità funzionale" del paziente.

| SCALA                    | PUNTEGGIO    | INTERPRETAZIONE | NOTE           |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Barthel Index            | ____ / 100   | _____           | _____          |
| IADL Lawton              | ____ / 8     | _____           | _____          |
| Tinetti (Balance + Gait) | ____ / 28    | _____           | _____          |
| TUG                      | ____ secondi | _____           | Ausilio: _____ |
| MMSE                     | ____ / 30    | _____           | _____          |
| GDS-15                   | ____ / 15    | _____           | _____          |

**SINTESI CLINICA (MAX 5 RIGHE)**

---

---

---

---

---

**OBIETTIVI TRIMESTRALI CONCORDATI**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Data valutazione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ • Prossima rivalutazione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ • Firma: \_\_\_\_\_

**Scheda 3 • Diario esercizi settimanale (7 giorni × 5 esercizi)**

Consegnata al paziente o al caregiver. Compilata a fine giornata con crocetta o nota breve. Va rivista ad ogni seduta.

| ESERCIZIO | LUN                      | MAR                      | MER                      | GIO                      | VEN                      | SAB                      | DOM                      |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| ESERCIZIO      | LUN                      | MAR                      | MER                      | GIO                      | VEN                      | SAB                      | DOM                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. _____       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Note / sintomi | _____                    | _____                    | _____                    | _____                    | _____                    | _____                    | _____                    |

Settimana dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. Paziente: \_\_\_\_\_. Note per il professionista alla prossima seduta: \_\_\_\_\_

## Scheda 4 • Registro cadute e quasi-cadute

Da consegnare al caregiver o da tenere in cartella. Ogni evento va annotato entro 24 ore — la memoria degli anziani sulle cadute è notoriamente inaffidabile.

| DATA     | ORA   | LUOGO | TIPO           | ATTIVITÀ IN CORSO | CONSEGUENZE | AUSILIO USATO? | FIRMA |
|----------|-------|-------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------|
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |
| __/__/__ | __:__ | _____ | Caduta / Quasi | _____             | _____       | Si / No: ____  | _____ |

### TRIGGER DI INTERVENTO

Se in un mese vengono registrate **≥ 2 cadute** o **≥ 3 quasi-cadute**, effettuare rivalutazione straordinaria Tinetti + TUG + ispezione ambientale del domicilio entro 7 giorni e comunicare al medico curante.

## Scheda 5 • Rivalutazione trimestrale comparativa

Da compilare in ogni rivalutazione (12 settimane). Il valore di questa scheda è il delta — la colonna della differenza rispetto al baseline.

| SCALA     | BASELINE | 3 MESI   | 6 MESI   | 9 MESI   | Δ TOT |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Barthel   | ____/100 | ____/100 | ____/100 | ____/100 | _____ |
| IADL      | ____/8   | ____/8   | ____/8   | ____/8   | _____ |
| Tinetti   | ____/28  | ____/28  | ____/28  | ____/28  | _____ |
| TUG (sec) | _____    | _____    | _____    | _____    | _____ |
| 6MWT (m)  | _____    | _____    | _____    | _____    | _____ |

| SCALA  | BASLINE | 3 MESI | 6 MESI | 9 MESI | Δ<br>TOT |
|--------|---------|--------|--------|--------|----------|
| MMSE   | ___/30  | ___/30 | ___/30 | ___/30 | ___      |
| GDS-15 | ___/15  | ___/15 | ___/15 | ___/15 | ___      |

#### CAMBIO DEL PIANO

In cosa cambia il piano nei prossimi 3 mesi:

\_\_\_\_\_

#### COMUNICAZIONI AL MEDICO

Elementi da segnalare al curante o al geriatra:

\_\_\_\_\_

## Scheda 6 • Report sintetico per la famiglia (senza jargon)

Una pagina in linguaggio accessibile per la famiglia. Non usa punteggi tecnici — usa parole. Consegna una copia, tieni una copia firmata.

**REPORT AL** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **PER LA FAMIGLIA DI** \_\_\_\_\_

### 1. Come sta oggi (autonomia)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2. Cosa è cambiato dalla scorsa valutazione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Cosa stiamo lavorando insieme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4. Cosa può fare la famiglia in questi 3 mesi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 5. Prossimo appuntamento di verifica \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma del professionista: \_\_\_\_\_ · Firma di un familiare (per ricevuta): \_\_\_\_\_

#### REGOLA D'ORO PER LA SCHEDA 6

Zero numeri, zero acronimi, zero termini clinici non spiegati. Se scrivi "Tinetti 22" la famiglia non capisce. Se scrivi "l'equilibrio è migliorato — cammina più stabile e ha meno bisogno del bastone" la famiglia capisce, si sente informata e si fida.

# Comunicare i risultati

La stessa valutazione va restituita in tre modi diversi a tre interlocutori diversi. Sbagliare il registro comunicativo azzerà il lavoro clinico che c'è dietro.

*Un punteggio non comunicato bene è un punteggio inutile. La famiglia lo può interpretare come sentenza, il medico come dato incompleto, il PAI come formalità burocratica. Cambia la lingua per ogni interlocutore — la sostanza clinica resta.*

## Alla famiglia — né allarmare né minimizzare

La famiglia oscilla tra due poli emotivi opposti: la **negazione** ("mio padre sta benissimo, siete voi che esagerate") e la **catastrofizzazione** ("è la fine, sta declinando"). Il tuo compito è tenerli in mezzo, sul piano del dato oggettivo e dell'azione praticabile.

### COSA NON DIRE

- "Il Tinetti è 18, alto rischio di caduta." (numero senza contesto)
- "Ha una demenza iniziale." (diagnosi fuori dal tuo ruolo)
- "Purtroppo peggiorerà." (prognosi non tua)
- "Va tutto bene." (rassicurazione falsa)

### COSA DIRE INVECE

- "L'equilibrio è nell'area di attenzione. Nei prossimi 3 mesi lavoriamo su queste 3 cose e rimisuriamo."
- "Ho notato alcuni segnali cognitivi che merita approfondire con il medico curante — vi preparo io la nota."
- "Oggi la situazione è X. Il piano è Y. Ci rivediamo tra Z settimane."
- "Ci sono cose che stanno andando bene (elencare) e cose su cui lavoriamo (elencare)."

## Al medico curante o al geriatra — la lingua dei numeri

Il medico legge report tutto il giorno. Vuole tre cose: punteggi con nome della scala esplicito, delta rispetto alla baseline, richiesta chiara. La comunicazione tipo — scritta o allegata alla cartella — segue questo schema in 4 righe:

### TEMPLATE DI COMUNICAZIONE AL MEDICO (4 RIGHE)

1. **Chi** — "Sig. Rossi, 82 anni, seguito da \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_"
2. **Cosa ho rilevato** — "Barthel 75 (baseline 80, -5), Tinetti 19 (baseline 22, -3), MMSE 24 (baseline 27, -3), GDS-15 8 (baseline 4, +4)."
3. **Cosa mi preoccupa** — "Peggioramento cumulativo cognitivo + emotivo in 3 mesi in assenza di eventi acuti dichiarati."
4. **Cosa chiedo** — "Valutazione clinica per esclusione cause reversibili (farmaci, deficit vitaminici, tiroide) e considerazione invio specialistica."

Quattro righe. Un foglio A5. Firmato. Datato. Consegnato al paziente o al caregiver perché lo porti alla visita successiva. Il medico ti risponderà — e il tuo ruolo professionale nella rete di cura sarà definito una volta per tutte.

## Nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato)

In RSA, centri diurni e servizi domiciliari strutturati, la valutazione entra nel PAI — il documento multidisciplinare che orienta l'assistenza. Il tuo contributo al PAI si limita a tre voci:

| VOCE DEL PAI            | COSA SCRIVI                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazione funzionale  | I punteggi delle scale somministrate, con data e chi le ha somministrate. Non l'interpretazione medica — solo i punteggi.                          |
| Obiettivi riabilitativi | 2-3 obiettivi funzionali SMART concordati col paziente/caregiver, con indicatore di verifica (quale scala/quale target) e scadenza (12 settimane). |
| Interventi              | Frequenza e tipologia delle sedute previste, ausili proposti, indicazioni per il caregiver o per il personale di assistenza.                       |

Il PAI si aggiorna ad ogni rivalutazione trimestrale — non si "chiude" mai. Se cambia il quadro funzionale, cambiano gli obiettivi. Se cambiano gli obiettivi, cambiano gli interventi. È un documento vivo, non un modulo.

### LA FIRMA È PIÙ IMPORTANTE DEL CONTENUTO

Un PAI perfetto non firmato non esiste. Firma sempre — nome, qualifica, data. In caso di contestazione, la firma è la prova che l'atto professionale è stato eseguito. Senza firma, hai fatto un esercizio di stile.

# Errori tipici della valutazione

Sei errori ricorrenti che ho visto in colleghi anche esperti — e ho fatto io stesso più di una volta. Se ne riconosci due, non sei un cattivo clinico. Se ne riconosci tutti e sei, è il momento di fermarti.

## ERRORE 1 · VALUTARE MENTRE IL PAZIENTE È STANCO O AGITATO

La valutazione dopo pranzo con un anziano assonnato produce numeri falsamente bassi che diventano una baseline finta. Tre mesi dopo, la rivalutazione sembra "migliorata" — ma stai solo tornando alla realtà. **Regola:** valuti solo in una fascia oraria in cui il paziente è tipicamente sveglio, riposato e collaborante. In caso contrario, riprogramma.

## ERRORE 2 · NON RIPORTARE I RISULTATI PER ISCRITTO

"Lo ricorderò io" è la bugia clinica più diffusa. Dopo cinque pazienti confondi i punteggi. Dopo un mese, hai perso metà dei dati. **Regola:** ogni scala somministrata va in cartella entro 24 ore. Nessuna eccezione. Un dato non scritto è un dato perso.

## ERRORE 3 · SALTARE LA RIVALUTAZIONE TRIMESTRALE

La rivalutazione a 12 settimane è il momento in cui la tua valutazione iniziale acquista senso. Senza rivalutazione, hai un dato statico — che non serve a niente. Se salti anche solo la prima, salterai anche la seconda. **Regola:** quando fai la baseline, blocca in agenda la data della rivalutazione. Non "quando ricordo" — un appuntamento vero.

## ERRORE 4 · CONFRONTARE PAZIENTI TRA LORO

Il paragone "il signor Bianchi al TUG faceva 10 secondi in meno" è clinicamente inutile e umanamente dannoso. Ogni paziente è un caso a sé — età, patologie, storia clinica, aspettative diverse. **Regola:** ogni paziente si confronta solo con sé stesso nel tempo. Il paragone tra pazienti è materia epidemiologica, non riabilitativa. Se lo fai davanti alla famiglia, hai perso la loro fiducia.

## ERRORE 5 · USARE SOLO SCALE COGNITIVE SENZA LE FISICHE (O VICEVERSA)

Un MMSE isolato racconta metà della storia. Un Tinetti isolato l'altra metà. La geriatria è multidimensionale per definizione — le due dimensioni interagiscono continuamente (la depressione riduce la mobilità, la caduta accelera il declino cognitivo). **Regola:** baseline sempre completa (fisica + cognitiva + emotiva). Le rivalutazioni possono essere parziali se il tempo è poco, ma la baseline no.

## ERRORE 6 · COMUNICARE I PUNTEGGI AL PAZIENTE IN MODO TECNICO

"Ha fatto 22 al Tinetti, che è rischio moderato" è una frase che ansiogena. Il paziente non sa cosa sia il Tinetti, non sa cosa sia rischio moderato, e resta con la parola "rischio" in testa per una settimana. **Regola:** al paziente e alla famiglia parli sempre in linguaggio funzionale ("l'equilibrio è nell'area di attenzione, lavoriamo su queste tre cose"). I numeri stanno in cartella e nella comunicazione al medico.



## Il metaerrore che li contiene tutti

Il denominatore comune di questi sei errori è uno: **trattare la valutazione come un adempimento invece che come uno strumento clinico**. Se la vivi come un modulo da compilare per la RSA o per il commercialista dell'aggiornamento, farai tutti e sei gli errori a rotazione. Se la vivi come il momento in cui vedi il paziente con gli occhi lucidi del dato — senza le distorsioni della memoria, della simpatia e della fatica di due mesi di sedute — nessuno di questi errori ti riguarderà a lungo.

La valutazione non è la parte noiosa del lavoro. È la parte che ti fa lavorare meglio in tutto il resto del tempo. È la parte che, dopo tre anni, ti fa dire: *"so cosa funziona e cosa no, perché ho i numeri"* — mentre i colleghi restano sull'aneddoto.

### CHIUSURA OPERATIVA

Se della guida ti rimane una sola cosa: **la valutazione è breve, ripetibile, difendibile e comunicabile**. Se manca uno di questi quattro attributi, non è valutazione geriatrica — è impressione clinica travestita da dato. Il paziente merita la differenza.

# Ora hai i numeri. Costruisci le sedute.

La valutazione ti ha dato la fotografia. Ora serve trasformarla in un piano operativo: quanti minuti di equilibrio, quali esercizi di forza, quante ripetizioni, in che ordine, per quale obiettivo.

## → Continua con Bonus 4

**Costruttore di Sedute** — la guida che trasforma i punteggi delle scale in sedute pronte, con protocolli passo-passo per ogni profilo funzionale rilevato: bassa autonomia, alto rischio caduta, deficit cognitivo, deconditioning, mobilità ridotta. Zero improvvisazione — apri, scegli, applica.